

Fecha Última Actualización: 19-07-2025 16:28:47

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Juana Yorka Caballero Rojas
Edad : 68a 6m 12d
Dirección : Río Puyehue 4197 Los Acacios

Rut : 7.510.357-3
Fecha Nacto: 07/01/1957
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : A230999
Sexo : Femenino
Teléfono : 945854869

N° Epicrisis
448516

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Hospitalización

Fecha Ingreso : 18/07/2025 21:22

Días Estadía : 1

Unidad de Egreso : Emergencia Adulto

Fecha Egreso : 19/07/2025 16:07

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Ictericia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

ANTECEDENTES

- Médicos: Ca de pulmon operado, Hipotiroidismo, HTA. T. Animo
- Quirúrgicos: Tu pulmon derecho hace 3 años.
- Medicamentos: levotiroxina, losartan, venlafaxina, mirtazapina.
- Alergias: ibuprofeno.
- Tóxicos: OH diario desde la juventud.

ANAMNESIS

Cuadro de 3 días de evolución caracterizado por baja de peso, anorexia, debilidad generalizada, sin molestia al orinar, además ictericia generalizada.

Examen físico de ingreso:

Vigil orientado en 3 planos, ictericia generalizada, rr2t mva en ambos hemitorax sin agregados, abdomen rhs con hepatomegalia, neuro sin focalidad.

Se solicitan exámenes de laboratorio y se hospitaliza para continuar estudio y manejo.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

1. Síndrome icterico en estudio
- Obs DHC descompensado

EXÁMENES

18/07: Láctico 25.7, Alb 2, BiliT 2.96, FA 496, GGT 1037, GOT 144, GPT 24, BUN 22.2, ELP 130/8.38 (hemólisis ++)/102, pH 7.41, pCO2 35.9, HCO3 22.5, LDH 1066 (hemólisis ++), PCR 100.3, Hb 15.2, GB 16.940, Plq 313.000, INR 1.65, TTPA 30

19/07: Láctico 12, LDH 412, ELP 132/4.65/101

SU: leucos 40-50, eritrocitos 10-15, piocitos 20-30

TAC de tórax, abdomen y pelvis (19/07):

1. Cambios morfológicos de daño hepático crónico asociado a moderada ascitis ascitis y circulación colateral

Fecha Epicrisis : 19/07/2025 16:28

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 19-07-2025 16:28:47

Página 2 de 3

como marcadores de hipertensión portal.

2. Signos de pielonefritis aguda bilateral, sin signos de complicación actual.
3. Colelitiasis.
4. Cambios postquirúrgicos de neumonectomía derecha, sin signos de recidiva local ni a distancia.

EVOLUCIÓN POR SISTEMA

Hemodinamia: estable, autosostenida.

Infeccioso: en exámenes de ingreso destaca con PPII elevados, sin foco infeccioso evidente por clínica, por lo que se realiza estudio con TAC TAP que evidencia PNA bilateral no complicada. Se inicia tratamiento con Ceftriaxona, actualmente en condiciones de continuar tratamiento antibiótico vía oral.

Gastroenterológico: debut de daño hepático crónico, con ascitis grado 2. Inicio tratamiento diurético y derivó a Medicina Interna y Gastroenterología en CDT para continuar estudio y seguimiento. Realizo interconsulta para EDA ambulatoria por DHC.

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO

1. Pielonefritis aguda bilateral no complicada
2. Debut DHC
 - Ascitis grado 2
3. Antecedentes: Cáncer pulmonar operado, Hipotiroidismo, HTA, Tr. ánimo

Diagnóstico de Egreso

INFECCION DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO -
FIBROSIS Y CIRROSIS DEL HIGADO -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente en buenas condiciones generales, hemodinámicamente estable, afebril, sin requerimientos de O₂ ni apremio ventilatorio. Buena tolerancia oral, sin náuseas. Actualmente sin dolor ni otras molestias. Diuresis espontánea conservada.

Plan Post Alta

Reposo relativo
Régimen hiposódico

Medicamentos:

- Ciprofloxacino 500 mg: 1 comprimido cada 12 horas, por 7 días
- Furosemida 40 mg: 1/2 comprimido al día (en la mañana), hasta control con médico del CDT
- Espironolactona 25 mg: 2 comprimidos al día, hasta control con médico del CDT
- Mantener resto de medicamentos de uso habitual

Controles:

- Entrego interconsulta para Medicina Interna y Gastroenterología en CDT, esperar llamado telefónico para agendar hora
- Continuar controles habituales con médico de consultorio

Consultar a urgencia en caso de fiebre (>38°C), dolor abdominal intenso persistente, vómitos con sangre, deposiciones negras como alquitrán y fétidas, desorientación persistente, o según estime necesario

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Hiposódico

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 19/07/2025 16:28

Página 2 de 3



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 19-07-2025 16:28:47

Página 3 de 3

INTERNO

Becado/Residente

Javiera Raasch Ponce

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 19/07/2025 16:28

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:25

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar